BESCHLUSSVORLAGE

STIFTUNG MERCATOR

Projekttitel	**Gesundes Vertrauen - Wie gute gesundheitliche Versorgung vor Ort die Demokratie stärken kann**
Projektnummer	250201
Bewilligungsverfahren	Schriftliches Bewilligungsverfahren
Antragsteller	Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung
Kofinanzierer	
Kooperationspartner	
Gesamtbudget	250.000,00 EUR
Projektbudget MD	250.000,00 EUR (davon 8.000,00 EUR Operativbudget)
Dritt- bzw. Eigenmittel	
Folgeprojekt	nein
Projektdauer	ein Jahr und sieben Monate

Projektmanager*in
Violaine Dobel
Datum
13.04.2026
Bereich
Teilhabe und Zusammenhalt

1 ANTRAG

Bewilligung des Projektbudgets in Höhe von 250.000,00 EUR für Gesundes Vertrauen - Wie gute gesundheitliche Versorgung vor Ort die Demokratie stärken kann für den Zeitraum vom 01.06.2026 bis 31.12.2027.

2 BEGRÜNDUNG

2.1 EINORDNUNG IN DIE MD-STRATEGIE

Im Bereich Teilhabe und Zusammenhalt verfolgt die Stiftung Mercator das Ziel, allen in Deutschland lebenden Menschen gerechte Teilhabechancen zu ermöglichen, um sozialer Ungleichheit entgegenzuwirken und damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die Demokratie zu stärken. Im Handlungsansatz Teilhabe im Sozialraum setzt die Stiftung an den Lebensbedingungen vor Ort an, indem sie die soziale Infrastruktur stärkt und Zugangsbarrieren für sozioökonomisch benachteiligte Menschen abbaut. Im Zentrum stehen dabei der Zugang zu bezahlbarem Wohnraum, Unterstützungsnetzwerke im Quartier sowie die Gesundheitsversorgung, da diese die Teilhabechancen in weiteren Lebensbereichen maßgeblich prägen. Die Gesundheitsversorgung wird dabei zunächst explorativ in den Blick genommen, mit dem Ziel, potenzielle Ansatzpunkte zur Verbesserung der Teilhabe – und somit zur Demokratiestärkung – zu identifizieren.

Das Projekt leistet hierzu einen konkreten Beitrag, indem es die Zusammenhänge zwischen ungleicher Gesundheitsversorgung und fehlendem Vertrauen in staatliche Institutionen analysiert, vielversprechende Ansätze für den Abbau gesundheitlicher Ungleichheit identifiziert und daraus Handlungsempfehlungen für relevante Akteur*innen ableitet.

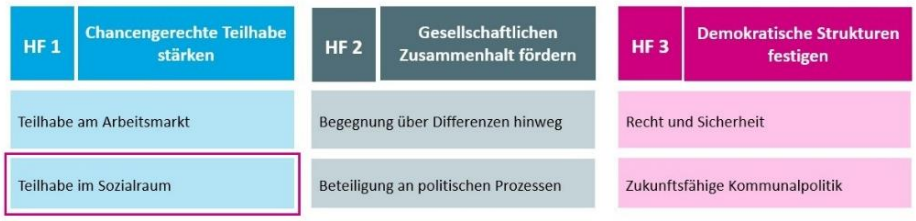

Abb. 1: Handlungsfelder und -ansätze Bereich Teilhabe und Zusammenhalt

2.2 AUSGANGSLAGE

Der gleichberechtigte Zugang zu Gesundheitsleistungen ist ein zentraler Bestandteil des demokratischen Versprechens von Chancengleichheit. Als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge hat die medizinische Versorgung großen Einfluss auf Gesundheit und Lebensqualität und ist eine Voraussetzung dafür, dass Menschen ihr Leben selbstbestimmt gestalten können. Laut Gleichwertigkeitsbericht der Bundesregierung sollte der Zugang zur Gesundheitsversorgung unabhängig vom Wohnort gewährleistet sein und allen Menschen verlässlich, erreichbar und in angemessener Qualität zur Verfügung stehen.[1]

Studien zeigen jedoch, dass der Gesundheitszustand stark vom sozioökonomischen Status und vom Wohnort abhängt. Menschen in Armutslagen erkranken häufiger, leiden stärker unter gesundheitlichen Einschränkungen und haben eine geringere Lebenserwartung.[2] Ursachen sind unter anderem belastende Arbeits- und Wohnbedingungen, eingeschränkter Zugang zu Präventionsangeboten, Unterschiede im Gesundheitsverhalten sowie erschwerter Zugang zu medizinischer Versorgung – insbesondere in ländlichen und sozial benachteiligten Regionen.[3]

Gesundheitliche Ungleichheit birgt nicht nur soziale Risiken, sondern hat auch demokratiepolitische Auswirkungen. Das Gesundheitssystem gehört zu den

---

[1] Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (2024), Gleichwertigkeitsbericht 2024, Für starke und lebenswerte Regionen in Deutschland, Gleichwertigkeitsbericht der Bundesregierung 2024 | BMWE

[2] Robert Koch Institut (2025), Public Health Reporting Germany 2025, RKI - Journal of Health Monitoring - Die Lebenserwartungslücke: Sozioökonomische Unterschiede in der Lebenserwartung zwischen Deutschlands Regionen - Journal of Health Monitoring 1/2025

[3] Lampert, T. und Hoebel, J. (2023), Soziale Ungleichheit und Gesundheit, Springer

zentralen Berührungspunkten zwischen Bürger*innen und Staat. Erfahrungen mit der Zugänglichkeit und Qualität medizinischer Versorgung prägen maßgeblich die Einschätzung, ob öffentliche Institutionen grundlegende Bedürfnisse zuverlässig erfüllen. Ob Arztpraxen, Präventionsangebote oder gesundheitsbegleitende Maßnahmen erreichbar und qualitativ hochwertig sind, beeinflusst das Vertrauen in staatliche Handlungsfähigkeit und die wahrgenommene Legitimität politischer Entscheidungen. Laut der Mitte-Studie besteht insbesondere in ländlichen Regionen eine deutliche Korrelation zwischen Versorgungsdefiziten, politischem Misstrauen und Radikalisierungstendenzen.[4] Dabei ist nicht nur die tatsächliche Versorgung relevant, sondern auch deren Wahrnehmung. So berichten Umfragen, dass vier von zehn Befragten in den letzten Jahren eine Verschlechterung der medizinischen Versorgung wahrgenommen haben – unter Personen mit rechtsextremen Einstellungen sogar sechs von zehn.[5]

Für die Gesundheitsversorgung sind unterschiedliche staatliche Ebenen zuständig: Während der Bund die gesundheits- und sozialpolitischen Rahmenbedingungen sowie Verordnungen setzt, sind die Länder für eine leistungsfähige und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung verantwortlich. Bund und Länder entscheiden über Förderprogramme und damit über die finanzielle Ausstattung vieler Maßnahmen. Die konkrete Umsetzung vor Ort liegt jedoch häufig bei den Kommunen. Bürgermeister*innen, Verwaltungen, Gesundheitsämter und zivilgesellschaftliche Akteur*innen können daher wichtige Impulse setzen.

Laut einer Befragung aus dem Jahr 2024 hat mehr als die Hälfte der ländlichen Kommunen bereits Maßnahmen ergriffen, um Hausärzt*innen zu gewinnen.[6] Viele haben darüber hinaus weitere Initiativen zur Sicherung oder Verbesserung der ambulanten Versorgung gestartet. Dabei sind in diversen Regionen vielfältige lokale Ansätze entstanden, beispielsweise Telemedizin, mobile Arztpraxen oder Gesundheitskioske. Sie zielen darauf ab, Menschen besser in ihrem Alltag zu erreichen und basieren häufig auf lokalen Netzwerken, die auch Akteur*innen außerhalb des klassischen Gesundheitssystems einbinden, wie etwa kommunale Einrichtungen, Sport- und Nachbarschaftsvereine, Betriebe, Schulen oder Einrichtungen der Jugendarbeit. Die Vielfalt dieser Initiativen zeigt, dass vielerorts bereits aktiv nach Lösungen gesucht und mit neuen Versorgungsmodellen experimentiert

---

[4] Neu, C., Eden, M. & Küpper, B. (2025), Raum, Daseinsvorsorge und Demokratie, In A. Zick, B. Küpper, N. Mokros & M. Eden (Hrsg.), Die angespannte Mitte. Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland 2024/25

[5] Forsa (2023), Umfrage zu Abschluss der „Initiative Neustart!“, Ergebnisse der bundesweiten Befragung (im Auftrag der Robert Bosch Stiftung)

[6] Bertelsmann Stiftung (2025), Hausärztliche Versorgung der Zukunft, Neue Empirie zu Plänen, Prognosen und Problemlösungen (Spotlight Gesundheit Nr. 1). Gütersloh

wird. Gleichzeitig bleiben viele dieser Ansätze lokal begrenzt und unterscheiden sich stark zwischen den Regionen: Es fehlen übergreifende Strategien und Strukturen, die erfolgreiche Modelle bündeln, weiterentwickeln und langfristig zum Abbau gesundheitlicher Ungleichheiten beitragen können.

Deutschland steht mit den Herausforderungen einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung nicht allein. Auch andere europäische Länder sehen sich mit vergleichbaren Problemlagen konfrontiert und haben bereits Erfahrungen mit lokalen Maßnahmen sowie mit nationalen Strategien gesammelt. Der Koalitionsvertrag 2025 sieht in den kommenden Jahren tiefgreifende Reformen zur Stärkung einer wohnortnahen, bezahlbaren und sektorenübergreifenden Gesundheitsversorgung vor, lässt jedoch in der praktischen Umsetzung noch viele Fragen offen. Daraus ergibt sich ein günstiges Zeitfenster, um diesen Reformprozess gezielt zu begleiten und Impulse für seine Ausgestaltung zu setzen.

Vor diesem Hintergrund besteht ein Bedarf, bestehende Ansätze zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung systematisch zu analysieren, ihre Wirkung auf gesellschaftliche Teilhabe und demokratisches Vertrauen – auch mit Blick auf internationale Erfahrungen – zu verstehen und diese Erkenntnisse für Zivilgesellschaft, Praxis und Politik nutzbar zu machen.

2.3 PROJEKTZIELE

Das Projekt „Gesundes Vertrauen - Wie gute gesundheitliche Versorgung vor Ort die Demokratie stärken kann“ (im Folgenden „Gesundes Vertrauen“ genannt) zielt darauf ab, die gesundheitliche Versorgung – sowohl in ihrer objektiven Ausgestaltung als auch in ihrer subjektiven Wahrnehmung – als gesellschaftliche und demokratiepolitische Herausforderung zu adressieren und insbesondere in ländlichen und strukturschwachen Räumen zu stärken.

Es untersucht, wie gesundheitliche Ungleichheit reduziert werden kann, welche Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung besonders wirksam sind und wie deren Beitrag zum Vertrauen in demokratische Strukturen ausgestaltet werden kann. Damit soll das Projekt Akteur*innen aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft konkrete Wege aufzeigen, um die Gesundheitsversorgung vor Ort leistungsfähiger zu machen und damit zugleich soziale Teilhabe und Vertrauen in staatliche Institutionen zu fördern.

2.4 PROJEKTBESCHREIBUNG

Das Projekt ist in vier aufeinander aufbauende Phasen gegliedert, die jeweils unterschiedliche Fragestellungen bearbeiten und eng miteinander verzahnt sind. Zunächst werden die Bedarfe und Wahrnehmungen der Bevölkerung sowie deren Zusammenhang mit dem Vertrauen in staatliche Institutionen analysiert (Bedarfsphase). Darauf aufbauend wird sichtbar gemacht, welche Lösungsansätze in Deutschland und anderen Ländern bereits existieren und welche davon besonders vielversprechend sind (Bestandsphase). In der dritten Phase wird vertieft untersucht, welche Rahmenbedingungen diese Ansätze fördern und wie daraus konkrete Handlungsschritte für Praxis und Politik abgeleitet werden können (Begleitphase). Die 4. Phase dient schließlich der Verbreitung der Ergebnisse und dem Agenda-Setting.

1. Bedarfsphase

Die Bedarfsphase untersucht, welche gesundheitlichen Angebote Menschen vor Ort benötigen, wie sie die bestehende Versorgung wahrnehmen und wie diese Wahrnehmung ihr Vertrauen in Staat und Politik beeinflusst. Ziel ist es, ein fundiertes Verständnis dafür zu gewinnen, wann Gesundheitsversorgung als gerecht, ausreichend und vertrauensstärkend erlebt wird und wann nicht.

Dazu wird zunächst der aktuelle Forschungsstand zu Versorgungsbedarfen, Angebotsstrukturen und deren Wirkung systematisch ausgewertet und durch Gespräche mit Verantwortlichen aus Bundes- und Landespolitik, mit dem Gesundheitssystem (z. B. Trägern von Gesundheitseinrichtungen, Verbänden oder Krankenkassen), sowie Vertreter*innen der Wissenschaft und Zivilgesellschaft ergänzt. Im zweiten Schritt werden vier ländliche und strukturschwache Regionen untersucht, die sich in unterschiedlichen Ausgangssituationen befinden.[7] In diesen Regionen werden Perspektiven von lokalen Akteur*innen und Bürger*innen zusammengeführt, um die zuvor identifizierten Zusammenhänge vor Ort zu konkretisieren und regionale Unterschiede sichtbar zu machen. Schließlich werden die Ergebnisse in einem überregionalen Workshop reflektiert und zentrale Kriterien für eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung herausgearbeitet.[8]

Ergebnis der Bedarfsphase ist ein belastbares Gesamtbild der Bedarfe und Wahrnehmungen sowie ein vertieftes Verständnis dafür, unter welchen Bedingungen Gesundheitsversorgung als bedarfsgerecht und

[7] Im Folgenden sind mit Regionen Gebiete gemeint, in denen gesundheitsbezogene Angebote oder Maßnahmen wirken. Dabei kann es sich auch um Gemeinden und Gemeindeverbände oder auch um größere Gebietseinheiten handeln.
[8] Kriterien können beispielsweise die räumliche Erreichbarkeit, eine partizipative Entwicklung, die Kontinuität der Betreuung oder die Sicherstellung der Fachkräfteverfügbarkeit sein.

vertrauensstärkend erlebt wird. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für die folgenden Projektphasen.

2. Bestandsphase

Während in der Bedarfsphase die Perspektive der Bevölkerung im Mittelpunkt steht, richtet sich der Blick nun auf bestehende Lösungen und deren Ausgestaltung: Die Bestandsphase untersucht, welche konkreten Ansätze zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung bereits existieren und welche davon besonders vielversprechend sind.

Dazu werden deutschlandweit 30 bis 50 vielversprechende Ansätze recherchiert, die sich an den zuvor identifizierten Kriterien orientieren – etwa Maßnahmen, die Menschen in ihrer Lebenswelt erreichen oder neue Formen der Zusammenarbeit ermöglichen. Die Ansätze werden vergleichbar gemacht und thematisch gebündelt, um unterschiedliche Herangehensweisen und Schwerpunkte sichtbar zu machen. Zudem werden ausgewählte Ansätze aus zwei europäischen Ländern einbezogen, die bereits weitergehende Strategien zur Verringerung gesundheitlicher Ungleichheiten verfolgen. Ziel ist es, zu verstehen, unter welchen politischen und strukturellen Rahmenbedingungen erfolgreiche Lösungen entstehen und welche übertragbaren Impulse sich daraus für den deutschen Kontext ergeben. Ein digitaler Expert*innenworkshop mit 10 bis 15 Vertreter*innen ausgewählter Ansätze dient schließlich dazu, das Gesamtbild einzuordnen und zu reflektieren. Dabei werden insbesondere Gemeinsamkeiten bei den Gelingensfaktoren sowie typische Hürden herausgearbeitet.

Ergebnis der Bestandsphase ist ein strukturierter Überblick über besonders inspirierende Ansätze und ihre zentralen Erfolgsbedingungen. Diese bilden die Grundlage für die vertiefende Analyse und die Ableitung konkreter Handlungsempfehlungen in der dritten Projektphase.

3. Begleitphase

Ziel der dritten Projektphase ist es, aus den gewonnenen Erkenntnissen konkrete Handlungsempfehlungen für Verantwortliche auf kommunaler Ebene sowie für politische Entscheidungsträger*innen auf Landes- und Bundesebene abzuleiten. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie erfolgreiche Ansätze in der Praxis entstehen, welche Kooperationen und Prozesse dafür entscheidend sind, wie bestehende Hürden überwunden werden und welche politischen Rahmenbedingungen positive Entwicklungen begünstigen können.

Hierfür werden zwei besonders überzeugende Ansätze aus dem identifizierten Pool für eine vertiefte Analyse ausgewählt. Diese liegen in anderen Regionen als die in Phase 1 untersuchten, sodass im Projekt insgesamt sechs ländliche Regionen betrachtet werden. Vor Ort wird untersucht, wie diese konkret umgesetzt werden und wie eine Skalierung gelingen kann: Dabei werden die Zusammenarbeit zwischen zentralen Akteur*innen, die Verteilung von Verantwortung, die Organisation vor Ort, die Nutzung durch die Bevölkerung sowie bestehende Herausforderungen und Weiterentwicklungsbedarfe in den Blick genommen. Um ein möglichst umfassendes Bild der Umsetzung zu gewinnen, werden dazu die Perspektiven der Beteiligten vor Ort ebenso einbezogen wie die Erfahrungen von Nutzer*innen.

Auf dieser Grundlage werden konkrete und umsetzbare Handlungsschritte für Praxis und Politik abgeleitet und in einem Workshop mit Vertreter*innen aller Regionen gemeinsam geschärft.

4. Verbreitungsphase

Die Ergebnisse aus allen drei Projektphasen werden in einer Abschlussstudie zusammengeführt sowie durch begleitende Formate verbreitet. Die ineinandergreifenden Publikationen verfolgen drei zentrale Ziele: Sie sollen 1. Verantwortliche motivieren, indem sie den konkreten Nutzen von Investitionen in Gesundheitsversorgung sichtbar machen (Bedarfsphase). Sie sollen 2. die Vielfalt gelingender Praxis aufzeigen (Bestandsphase) und sie sollen 3. Gesundheitsakteur*innen aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft konkrete Handlungsschritte an die Hand geben, wie sie die ländliche Gesundheitsversorgung fördern und weiterentwickeln können (Begleitphase).

Neben der Abschlussstudie werden die Handlungsempfehlungen in zwei zielgruppenspezifischen Formaten aufbereitet: für lokale Verantwortliche in Form einer kurzen Broschüre, die – statt abstrakter Appelle – konkrete Handlungsschritte für den Weg zu einer chancengerechten Gesundheitsversorgung vor Ort aufzeigt sowie für Verantwortliche auf Bundes- und Landesebene in Form eines Policy Papers mit Fact Sheets und konkreten Ansatzpunkten für künftige Reformen.

Diese Veröffentlichungen werden von einer umfangreichen Öffentlichkeitsarbeit begleitet (u. a. Studienpräsentation, Pressekonferenz und Social-Media-Arbeit) und in einer kurzen hybriden Abschlussveranstaltung mit Webinar-Charakter für lokale und bundesweite Stakeholder sowie für Medien vorgestellt.

3 BEWERTUNG

Das Berlin-Institut ist ein unabhängiger Think Tank mit fundierter Expertise zu demografischem Wandel, regionalen Lebensverhältnissen und gesellschaftlicher Teilhabe. Es hat bereits erfolgreich Mercator-Projekte umgesetzt (u. a. „Teilhabe für alle – Kommunale Integrationsarbeit nicht nur für Zugewanderte“, PN 200239) und verfügt über Erfahrung im Gesundheitsbereich (z. B. in Projekten wie „Hohes Alter – aber nicht für alle“, „Smart Ageing“, Teilhabeatlas). Seine Stärke liegt in der Verbindung von analytischer Tiefe und konkreten Impulsen für politische Entscheidungsprozesse.

Die Transformation gesundheitlicher Versorgung in ländlichen Räumen ist bereits Gegenstand verschiedener Projekte im Feld, etwa zur Entwicklung neuer Versorgungsmodelle, zur Stärkung der Gesundheitskompetenz oder zur besseren Erreichbarkeit bestimmter Bevölkerungsgruppen. „Gesundes Vertrauen“ setzt hier einen eigenen Akzent: Es verbindet eine breite Analyse bestehender Angebote mit einer vertieften Untersuchung des Zusammenhangs zwischen ländlicher Gesundheitsversorgung und Vertrauen in staatliche Institutionen.

Das vorgeschlagene Projekt ist als zentraler erster Schritt im explorativen Ansatz der Stiftung Mercator zur Gesundheitsversorgung vor Ort konzipiert. Es liefert nicht nur Erkenntnisse für Verantwortliche auf Bundes- und kommunaler Ebene, sondern eröffnet der Stiftung zugleich einen strukturierten Zugang zu relevanten Themen, Akteur*innen und Netzwerken. Gerade zum Start der Strategie MD2030 ermöglicht es eine fundierte Grundlage, um Ansatzpunkte für künftige Förderaktivitäten und Experimentierräume für den dritten Sektor zu identifizieren.

Damit verwirklicht das Projekt die steuerbegünstigten Zwecke „Förderung von Wissenschaft und Forschung“ (§ 52 Abs. 2 Ziff. 1 AO), „Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens“ (§ 52 Abs. 2 Ziff. 3 AO) und „Förderung des demokratischen Staatswesens“ (§ 52 Abs. 2 Ziff. 24 AO).

4 EVALUATION UND WIRKUNG

4.1 OUTPUT UND OUTCOME

Outputs:

- bis zu 50 Interviews bundesweit mit relevanten Stakeholdern
- vertiefte Analysen in bis zu sechs Regionen
- vier Fokusgruppen mit Bürger*innen

- drei überregionale Workshops und zwei Workshops in den Begleitregionen
- 30 bis 50 gute Beispiele in Deutschland und bis zu 5 gute Beispiele in zwei europäischen Ländern
- konkrete Handlungsempfehlungen für lokale Verantwortliche und politische Entscheidungsträger*innen
- Abschlussstudie und hybride Abschlussveranstaltung
- Broschüre mit Handlungsschritten für lokale Stakeholder
- Policy Paper für Bundes- und Landesebene
- Beiträge für das digitale Magazin der Stiftung Mercator

Outcomes:
- neue Erkenntnisse zu den Bedürfnissen der Menschen bezüglich Gesundheitsversorgung
- neue Erkenntnisse zu den Zusammenhängen zwischen (realer oder wahrgenommener) Gesundheitsversorgung und Vertrauen in demokratische Institutionen
- Verbesserung der gesundheitlichen Teilhabe in ländlichen Regionen
- Verringerung der sozioökonomischen Unterschiede in Bezug auf Gesundheitsversorgung

4.2 MEILENSTEINE

Q4 2026: Ergebnisse der Bedarfsphase liegen vor
Q1 2027: Katalog über vielversprechende Ansätze wurde erstellt
Q3 2027: Handlungsempfehlungen wurden abgeleitet und mit wichtigen Stakeholdern geschärft
Q3 und Q4 2027: Verbreitung der Projektergebnisse durch Veröffentlichung verschiedener Projektpublikationen

4.3 EVALUATIONSKRITERIEN

Das Projekt verfolgt einen explorativen und wissenschaftlichen Ansatz. Eine Projektevaluation ist daher nicht vorgesehen.

5 ANLAGEN

5.1 FINANZPLAN

Der Finanzplan ist durch den Kaufmännischen Bereich geprüft.